MINISTERIO DE SALUD

No. 159-2026/MINSA

REPUBLICA DEL PERU

Resolución Ministerial

Lima, 25 de FEBRERO del 2026

Visto, el Expediente N° DGAIN020230000632, que contiene el Informe N° D000047-2026-DGAIN-DIPOS-MINSA, la Nota Informativa N° D000103-2026-DGAIN-MINSA y el Proveído N° D000644-2026-DGAIN-MINSA de la Dirección General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional; el Informe N° D000006-2026-DGOS-DIEM-MGS-MINSA, el Informe N° D000015-2026-DGOS-DIMON-JVB-MINSA y el Memorándum N° D000312-2026-DGOS-MINSA de la Dirección General de Operaciones en Salud; así como el Proveído N° D005273-2026-DVMPAS-MINSA del Despacho Viceministerial de Prestaciones y Aseguramiento en Salud; y el Informe N° D000207-2026-OGAJ-MINSA, elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,

MINISTERIO DE SALUD - DIRECCIÓN GENERAL
B. OSTOS

CONSIDERANDO:

Que, los numerales I, II y VI del Título Preliminar de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, establecen que la salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo; que la protección de la salud es de interés público y por tanto es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla; y que es de interés público la provisión de servicios de salud, cualquiera sea la persona o institución que los provea, siendo responsabilidad del Estado promover las condiciones que garanticen una adecuada cobertura de prestaciones de salud a la población, en términos socialmente aceptables de seguridad, oportunidad y calidad;

MINISTERIO DE SALUD - OGAJ - ASESORÍA JURÍDICA
J. DEDIOS

Que, el numeral 1) del artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1161, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, establece que el Ministerio de Salud es competente en la Salud de las Personas;

MINISTERIO DE SALUD - Dirección General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional
C. ALVARADO CH.

Que, el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1161, dispone que el Sector Salud está conformado por el Ministerio de Salud, como organismo rector, las entidades adscritas a él y aquellas instituciones públicas y privadas de nivel nacional, regional y local, y las personas naturales que realizan actividades vinculadas a las competencias establecidas en dicha Ley, y que tienen impacto directo o indirecto en la salud, individual o colectiva;

S. MONZÓN

Que, el artículo 4-A del precitado Decreto Legislativo, modificado por el Decreto Legislativo N° 1504, Decreto Legislativo que fortalece al Instituto Nacional de Salud para la prevención y control de las enfermedades, refiere que la potestad rectora del Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD - Secretaría General
C. LINARES

comprende la facultad que tiene para normar, supervisar, fiscalizar y, cuando corresponda, sancionar, en los ámbitos que comprenden la materia de salud, así como que la rectoría en materia de salud dentro del sector la ejerce el Ministerio de Salud por cuenta propia o, por delegación expresa, a través de sus organismos públicos adscritos y, dentro del marco y los límites establecidos en la mencionada ley, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, las normas sustantivas que regulan la actividad sectorial y, las normas que rigen el proceso de descentralización. Asimismo, que el Ministerio de Salud, ente rector del Sistema Nacional de Salud, y dentro del ámbito de sus competencias, determina la política, regula y supervisa la prestación de los servicios de salud, a nivel nacional, en las siguientes instituciones: Essalud, Sanidad de la Policía Nacional del Perú, Sanidad de las Fuerzas Armadas, instituciones de salud del gobierno nacional y de los gobiernos regionales y locales, y demás instituciones públicas, privadas y público-privadas;

Que, los literales a) y e) del artículo 5 del Decreto Legislativo N° 1161, modificado por el Decreto Legislativo N° 1504, establecen que son funciones rectoras del Ministerio de Salud, conducir, regular y supervisar el Sistema Nacional de Salud, así como, regular y dictar normas de organización para la oferta de salud, de los diferentes prestadores que brindan atenciones, para que en conjunto sean integrales, complementarias, de calidad, y que preste cobertura de manera equitativa y eficiente a las necesidades de atención de toda la población;

Que, el literal a) del artículo 7 del Decreto Legislativo N° 1161, modificado por la Ley N° 30895, Ley que fortalece la función rectora del Ministerio de Salud, señala que el Ministerio de Salud cumple la función específica de regular la organización y prestación de servicios de salud;

Que, el artículo 98 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2017-SA, establece que la Dirección General Aseguramiento e Intercambio Prestacional es el órgano de línea del Ministerio de Salud, dependiente del Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, responsable de proponer normatividad en materia de organización y gestión de servicios en salud;

Que, los literales a) y g) del artículo 102 del precitado reglamento, establecen que son funciones de la Dirección de Intercambio Prestacional, Organización y Servicios de Salud, formular las políticas sectoriales, normas, lineamientos, estándares y demás documentos en materia de organización, funcionamiento, gestión y control de los servicios de salud; así como, monitorear y evaluar sus resultados, así como, formular normas, requisitos y condiciones para la operación y funcionamiento de los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, orientados a garantizar la calidad de sus prestaciones;

Que, el literal e) del numeral 15.1 del artículo 15 de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, modificado por la Ley N° 29414, Ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud, dispone que toda persona tiene derecho a obtener servicios, medicamentos y productos sanitarios adecuados y necesarios para prevenir, promover, conservar o restablecer su salud, según lo requiera la salud del usuario, garantizando su acceso en forma oportuna y equitativa;

Que, el artículo 10 del Reglamento de la Ley N° 29414, Ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud, aprobado mediante Decreto Supremo N° 027-2015-SA, señala que toda persona tiene derecho a obtener servicios, medicamentos y productos sanitarios adecuados y necesarios para prevenir, promover, conservar o restablecer su salud, según lo requiera la salud de la persona usuaria, de acuerdo a las guías de práctica clínica, el uso racional de los recursos y según la capacidad de oferta de la IPRESS y cobertura contratada con la IAFAS; así como, que la IPRESS y UGIPRESS deben garantizar el acceso a

MINISTERIO DE SALUD

No. 159-2026/MINSA

REPUBLICA DEL PERU

Resolución Ministerial

Lima, 25 de FEBRERO del 2026

los servicios, medicamentos y productos sanitarios en forma oportuna y equitativa a fin de satisfacer la necesidad de sus personas usuarias, en el marco de los compromisos asumidos con la IAFAS y la normatividad vigente;

Que, el Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-2006-SA, tiene como objeto establecer los requisitos y condiciones para la operación y funcionamiento de los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, orientados a garantizar la calidad de sus prestaciones, así como los mecanismos para la verificación, control y evaluación de su cumplimiento;

Que, la Novena Disposición Complementaria del precitado reglamento dispone que, por Resolución del Ministerio de Salud, se expedirán las normas sanitarias aplicables a cada uno de los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo mencionados en los artículos 45, 52 y 85 de dicho reglamento, y las que sean necesarias para su aplicación;

Que, la NTS N° 021-MINSA/DGSP-V.03 Noma Técnica de Salud "Categorías de Establecimientos del Sector Salud", aprobada mediante Resolución Ministerial N° 546-2011/MINSA, regula en la organización de los servicios de salud a las unidades productoras de servicios de salud;

Que, el numeral 5.1 de la precitada norma técnica de salud, define a la Unidad Productora de Servicios de Salud como la Unidad Productora de Servicios organizada para desarrollar funciones homogéneas y producir determinados servicios de salud, en relación directa con su nivel de complejidad;

Que, mediante la Resolución Ministerial N° 115-2026/MINSA, se aprueba la NTS N° 244-MINSA/DGAIN-2026, Norma Técnica de Salud Unidad Productora de Servicios de Salud Cuidados Intensivos – UPSS Cuidados Intensivos, con la finalidad de contribuir a mejorar la calidad, seguridad y oportunidad de la atención de salud de los pacientes en estado crítico en los establecimientos de salud a nivel nacional que cuentan con Unidad Productora de Servicios de Salud Cuidados Intensivos;

Que, de acuerdo a lo señalado en los documentos del visto, la Dirección General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional, en el marco de sus funciones, ha considerado

MINISTERIO DE SALUD – DIRECCIÓN GENERAL – B. OSTOS

MINISTERIO DE SALUD – Dirección General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional – C. ALVARADO CH.

MINISTERIO DE SALUD – O.G. ASESORÍA JURÍDICA – J. DEGOS

MINISTERIO DE SALUD – Aseguramiento e Intercambio Prestacional – S. MONZÓN

MINISTERIO DE SALUD – Secretaría General – C. LINARES

modificar la precitada norma técnica de salud, con el fin de optimizar su implementación, garantizando una adecuada atención de salud a los pacientes críticos en los establecimientos de salud a nivel nacional; habiendo obtenido para esto la conformidad del Despacho Viceministerial de Prestaciones y Aseguramiento en Salud;

Estando a lo propuesto por la Dirección General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional;

Con el visado de la Dirección General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional, de la Dirección General de Operaciones en Salud, de la Oficina General de Asesoría Jurídica y del Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud; y;

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1161, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, modificado por la Ley N° 30895, Ley que fortalece la función rectora del Ministerio de Salud, así como, por el Decreto Legislativo N° 1504, Decreto Legislativo que fortalece al Instituto Nacional de Salud para la prevención y control de las enfermedades; y el Decreto Supremo N°008-2017- SA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, modificado por los Decretos Supremos N° 011-2017-SA y N° 032-2017-SA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Modificar la NTS N° 244-MINSA/DGAIN-2026, Norma Técnica de Salud Unidad Productora de Servicios de Salud Cuidados Intensivos – UPSS Cuidados Intensivos, aprobada mediante la Resolución Ministerial N° 115-2026/MINSA, conforme al Anexo que forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial, y que se publica en la sede digital del Ministerio de Salud.

Artículo 2.- Sustituir en los literales c) y d) del numeral 6.2.1, en los subnumerales 1 y 2 del literal b) del numeral 6.4.1, en el literal f) del subnumeral 6.4.10, en el literal k) del subnumeral 6.7.3.4, en la viñeta al pie del ANEXO N° 4, y en la viñeta al pie del ANEXO N° 5, de la NTS N° 244-MINSA/DGAIN-2026, Norma Técnica de Salud Unidad Productora de Servicios de Salud Cuidados Intensivos – UPSS Cuidados Intensivos, aprobada mediante la Resolución Ministerial N° 115-2026/MINSA, el término "de especialidades" por "especializados".

Artículo 3.- Dejar sin efecto los numerales 5.18, 6.2.10, 6.2.11; los literales b), f) y g) del numeral 6.6; los numerales 6.6.2.3, 6.6.2.6, y 7.1.3, asimismo, el extremo referido a la "Zona de pacientes" de la tabla obrante en el numeral 6.7.2, de la NTS N° 244-MINSA/DGAIN-2026, Norma Técnica de Salud Unidad Productora de Servicios de Salud Cuidados Intensivos – UPSS Cuidados Intensivos, aprobada mediante la Resolución Ministerial N° 115-2026/MINSA.

Artículo 4.- Encargar a la Oficina de Transparencia y Anticorrupción de la Secretaría General la publicación de la presente Resolución Ministerial y su Anexo en la sede digital del Ministerio de Salud (www.gob.pe/minsa), en la misma fecha de publicación de la presente resolución en el diario oficial El Peruano.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

LUIS NAPOLEÓN QUIROZ AVILÉS
Ministro de Salud

ANEXO

MODIFICACIÓN DE DIVERSOS NUMERALES, LITERALES Y ANEXOS DE LA NTS N° 244-MINSA/DGAIN-2026, NORMA TÉCNICA DE SALUD UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS DE SALUD CUIDADOS INTENSIVOS – UPSS CUIDADOS INTENSIVOS, APROBADA POR LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 115-2026/MINSA

1. Modificar los numerales 5.1.7, 5.1.18, 5.1.31, 5.1.32, 5.1.35, 5.8, 5.10, 5.14 y 5.16 de la NTS N° 244-MINSA/DGAIN-2026, Norma Técnica de Salud Unidad Productora de Servicios de Salud Cuidados Intensivos – UPSS CUIDADOS INTENSIVOS, aprobada por la Resolución Ministerial N° 115-2026/MINSA, que quedan redactados de la siguiente manera:

"5.1 DEFINICIONES OPERATIVAS

(...)

5.1.7 Equipo de Respuesta Rápida Intensiva ERRI de Cuidados Intensivos Extendidos

Es el equipo de profesionales de la salud que brindan cuidados intensivos extendidos, en UPSS distintas a la UPSS Cuidados Intensivos, encargado de efectuar la evaluación de pacientes en evolución hacia un estado crítico, o en estado crítico, bajo la modalidad de interconsulta o por búsqueda activa de casos. Estos equipos son conformados por médico cirujano especialista en medicina intensiva y profesional en enfermería especialista en cuidados intensivos y técnica capacitada en el manejo del paciente crítico del establecimiento de salud, los cuales deben estar programados formalmente en forma exclusiva para esta actividad."

(...)

5.1.18 Médico tratante en Cuidados Intensivos

En cuidados intensivos el profesional médico especialista en medicina intensiva, es el médico tratante responsable del manejo del paciente crítico. El médico tratante es aquel que atiende según programación de un servicio en tanto permanezca en éste. Cuando el paciente es trasladado e ingresa a otro servicio o unidad, el médico tratante es aquel que asume su tratamiento médico o quirúrgico.

(...)

5.1.31 Unidad de Cuidados Intensivos Especializados

Es la unidad que brinda una modalidad de atención de salud a un paciente cuyo estado crítico y con posibilidades de recuperación están generados por un grupo de patologías específicas relacionados a un determinado campo clínico o grupo etario. El estado crítico es de exclusiva atención del médico especialista en medicina intensiva o de alguna de las subespecialidades de la medicina intensiva. Esta unidad pertenece a la Unidad Productora de Servicios de Salud Cuidados Intensivos.

C. ALVARADO CH.

5.1.32 Unidad de Cuidados Intermedios Especializados

Es la unidad que brinda una modalidad de atención de salud especializada al paciente cuyo estado crítico está generado por una patología que corresponde ser atendido por una determinada especialidad o subespecialidad médica, o en relación a un determinado campo clínico o grupo etario, cuyo estado crítico es de gravedad momentánea o persistente, pero menor que el de la Unidad de Cuidados Intensivos especializados.

(...)

5.1.35 Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos

Es la unidad que brinda atención de salud especializada al paciente pediátrico en estado crítico, que necesita monitoreo permanente de sus funciones vitales, con apoyo tecnológico y procedimientos médicos especializados, cuya atención corresponde a la especialidad de medicina intensiva pediátrica.

(...)

5.8 *El médico cirujano especialista en medicina intensiva conduce la gestión clínica de la Unidad de Cuidados Intensivos Generales, de la Unidad de Cuidados Intensivos Especializados y de la Unidad de Cuidados Intermedios Generales de la UPSS Cuidados Intensivos.*

(...)

5.10 *El médico cirujano especialista en neonatología o el médico cirujano especialista en pediatría con subespecialidad en neonatología, conduce la gestión clínica de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y de la Unidad de Cuidados Intermedios Neonatales.*

(...)

5.14 *Los Comités Farmacoterapéuticos de los establecimientos de salud, autorizan el uso de medicamentos no incluidos en el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales PNUME para los pacientes de la UPSS Cuidados Intensivos, a través del procedimiento que contempla la Resolución Ministerial N° 540-2011/MINSA, que aprueba la "Norma Técnica de Salud para la Utilización de Medicamentos no incluidos en el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales PNUME"; o norma que haga sus veces.*

(...)

5.16 *En el establecimiento de salud con UPSS Cuidados Intensivos, el médico cirujano especialista en medicina intensiva puede realizar teleinterconsulta a médicos cirujanos de otras especialidades o de las unidades de cuidados intensivos especializados que atienden a pacientes en estado crítico, si lo requieren."*

C. ALVARADO CH.

2. Modificar los numerales 6.2.2, 6.2.3, 6.2.6, 6.2.7, el literal h) del subnumeral 6.2.14, el literal a) del subnumeral 6.2.15.2, el literal b) del subnumeral 6.3.1, los literales b) y c) del subnumeral 6.3.2, el numeral 6) del literal e) del subnumeral 6.3.2, el literal c) del

subnumeral 6.3.4, los subnumerales 6.3.4.1 y 6.3.4.3, los literales a), b) y c) del subnumeral 6.4.1, el literal c) del subnumeral 6.4.6, el literal j) del subnumeral 6.5.1, el literal a) Del Paciente, el literal a) Del Trabajador y el literal a) Del Ambiente del subnumeral 6.5.2, el literal a) del numeral 6.6, el literal a) del subnumeral 6.6.1, el literal l) del subnumeral 6.6.2.1, los literales f), h) y k) del subnumeral 6.6.2.2, el literal d) del numeral 6.6.2.5, el literal k) del numeral 6.7.3.4 y el literal d) del numeral 6.9, así como, la Tabla N° 3 obrante en el literal e) del numeral 6.6, de la NTS N° 244-MINSA/DGAIN-2026, Norma Técnica de Salud Unidad Productora de Servicios de Salud Cuidados Intensivos – UPSS CUIDADOS INTENSIVOS, aprobada por la Resolución Ministerial N° 115-2026/MINSA, los cuales quedan redactados como sigue:

"(...)

6.2.2 *En la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos se garantiza la atención de salud del paciente en estado crítico, con la presencia del médico cirujano especialista en pediatría con subespecialidad en medicina intensiva pediátrica; y, de forma complementaria, con médicos cirujanos especialistas en pediatría, o de otras subespecialidades pediátricas, capacitados en cuidados intensivos pediátricos.*

6.2.3 *En la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales se garantiza la atención de salud del neonato en estado crítico, con la presencia del médico cirujano especialista en neonatología o del médico cirujano especialista en pediatría con subespecialidad en neonatología; y, de forma complementaria, con médicos cirujanos especialistas en pediatría, o de otras subespecialidades pediátricas, capacitados en cuidados intensivos pediátricos.*

(...)

6.2.6*. La UPSS Cuidados Intensivos implementa de manera permanente medidas de prevención y control de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud - IAAS en su ámbito asistencial.*

(...)

6.2.7*.La UPSS Cuidados Intensivos aplica precauciones estándar y precauciones basadas en el mecanismo de transmisión (contacto, gotas, aérea) según evaluación clínica y normativa vigente, en coordinación con la Oficina/Unidad de Epidemiología o el que haga sus veces, especialmente ante casos inusuales o brotes.*

(...)

6.2.14 CUIDADOS INTENSIVOS EXTENDIDOS

(...)

h) El equipo de respuesta rápida intensiva ERRI, en coordinación y de forma conjunta con el médico cirujano tratante, realiza acciones terapéuticas precoces como: inicio de oxigenoterapia, soporte ventilatorio invasivo, inicio de sistema de alto flujo de oxígeno, colocación de catéter venoso central, inicio de vasopresores, reanimación cardiopulmonar; abre hojas de monitoreo según los protocolos, guías de práctica clínica y guías técnicas de procedimientos médicos establecidos, para revertir el estado de gravedad del paciente o en caso contrario, para el traslado e ingreso del paciente a la UPSS Cuidados Intensivos.

(...)

6.2.15.2 UNIDAD DE SOPORTE EN TERAPIA NUTRICIONAL ESPECIALIZADA (UTNE) O UNIDAD DE SOPORTE NUTRICIONAL Y METABÓLICA O SERVICIO PARA TERAPIA NUTRICIONAL ESPECIALIZADA.

(...)

a) Conformada por un equipo multidisciplinario e interdisciplinario de profesionales de la salud capacitados y entrenados en soporte nutricional o terapia nutricional especializada, integrado principalmente por: médico cirujano especialista en medicina intensiva, y/o médico cirujano pediatra especialista en medicina intensiva pediátrica, y/o médico cirujano especialista en neonatología, profesional en enfermería especialista en cuidados intensivos, o capacitada en cuidados intensivos; químico farmacéutico especialista y con conocimiento, experiencia y entrenamiento en terapia nutricional parenteral y enteral especializada, y licenciado/a en nutrición con especialidad en nutrición clínica y/o capacitado/a en soporte nutricional.

(...)

6.3.1 PLANIFICACIÓN

El médico cirujano especialista en medicina intensiva, que conduce la gestión clínica de la UPSS Cuidados Intensivos:

(...)

b) Gestiona la existencia, disponibilidad, operatividad y buen estado de conservación del equipamiento o instrumental médico, electromédico, eléctrico y mecánico.

(...)

6.3.2 ORGANIZACIÓN

(...)

b) El médico cirujano especialista en medicina intensiva conduce la gestión clínica de las Unidades de Cuidados Intensivos Generales, Cuidados Intensivos Especializados y Cuidados Intermedios Generales de la UPSS Cuidados Intensivos.

c) El profesional en enfermería especialista en cuidados intensivos responsable de enfermería en la UPSS Cuidados Intensivos, conduce los procesos de atención de enfermería; tiene responsabilidad sobre el profesional en enfermería especialista en cuidados intensivos, y capacitado en cuidados intensivos, sobre la realización de los procedimientos de enfermería, la programación del personal en enfermería, así como sobre la gestión de los bienes de la UPSS Cuidados Intensivos y de la operatividad de los equipos en dicha UPSS.

(...)

e) En la gestión clínica de la UPSS Cuidados Intensivos se tiene en cuenta la siguiente información (registros):

6) Registro y notificación de incidentes de la seguridad del paciente en la UPSS Cuidados Intensivos.



(…)

6.3.4 CONTROL

El médico cirujano especialista en medicina intensiva que conduce la gestión clínica de la UPSS Cuidados Intensivos:

(…)

c) Notifica los casos relevantes de Morbilidad Materna Extrema que hayan estado en la UPSS Cuidados Intensivos, y los presenta al Comité de Prevención de Mortalidad Materna, Fetal y Neonatal del establecimiento de salud, para el análisis, la toma de decisiones y de las medidas correspondientes, de acuerdo a la normatividad vigente.

(…)

6.3.4.1 AUDITORÍA DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN SALUD

- *El médico cirujano especialista en medicina intensiva que conduce la gestión clínica de la UPSS Cuidados Intensivos aprueba el Plan de Mejora de los procesos de atención y de gestión clínica en la UPSS Cuidados Intensivos, en base a las recomendaciones de las Auditorías médicas, que incluye las auditorías programadas y las auditorias de caso, con la finalidad de reducir los incidentes relacionados con la seguridad del paciente.*

(…)

6.3.4.3 INDICADORES MÁS FRECUENTES A USARSE EN LA UPSS CUIDADOS INTENSIVOS

(…)

b) Indicadores de Calidad:

(…)

- ***Indicadores de Procesos***

iii) Porcentaje de Registro, Notificación y Gestión de incidentes de la seguridad del paciente, según clasificación OMS: cuasi accidentes (near miss), eventos adversos, eventos centinela.

(…)

v) Implementación de Prácticas de Prevención y control de infecciones: Densidad de incidencia de neumonía asociada a ventilador mecánico.

vi) Implementación de Prácticas de Prevención y control de infecciones: Densidad de incidencia de infección asociada a catéter venoso central.

vii) Implementación de Prácticas de Prevención y control de infecciones: Densidad de incidencia de infección del tracto urinario asociada a catéter urinario.

(…)

ix) Porcentaje de pacientes con lesiones por presión grado 3 o 4 adquiridas en la UPSS Cuidados Intensivos.

(…)

C. ALVARADO CH.

xi) *Razón de incidentes de la seguridad del paciente por egresos hospitalarios de la UPSS Cuidados Intensivos.*

(…)

6.4.1. EVALUACIÓN PREVIA AL INGRESO A LA UPSS CUIDADOS INTENSIVOS

a) *El proceso de atención del paciente en estado crítico o en riesgo de estarlo, comienza en la UPSS donde se encuentra el paciente; el médico cirujano responsable del paciente, genera la interconsulta a la UPSS Cuidados Intensivos, presenta al paciente critico potencialmente recuperable al médico interconsultante y efectiviza las sugerencias dejadas por el medico intensivista.*

b) *La evaluación al paciente en estado crítico o en riesgo de estarlo, la realiza el médico cirujano especialista en medicina intensiva de la UPSS Cuidados Intensivos; una vez evaluado el paciente y calificándosele como paciente en estado crítico y recuperable, se siguen los flujogramas establecidos en el Anexo N° 6: Flujograma de atención del paciente en estado crítico en el establecimiento de salud Categoría II-2 y en el Anexo N° 7: Flujograma de atención del paciente en estado crítico en el establecimiento de salud Categorías III-1, III- 2, III E, a fin de la toma de decisiones en Medicina Intensiva, que implica su derivación a:*

(…)

c) *Si se considera que el paciente no tiene criterios de ingreso a la unidad de cuidados intensivos o a la unidad de cuidados intermedios de la UPSS Cuidados Intensivos, permanecerá en la misma UPSS con las sugerencias del médico cirujano especialista en medicina intensiva y bajo el manejo de la UPSS que solicitó la interconsulta. Anexo N° 7: Flujograma de atención del paciente en estado crítico en el establecimiento de salud Categorías III-1, III- 2, III E.*

(…)

6.4.6 INTERCONSULTAS

(…)

c) *Las interconsultas de otras UPSS solicitadas a la UPSS Cuidados Intensivos, son atendidas por el médico cirujano especialista en medicina intensiva de turno programado en cuidados intensivos extendidos, cuando exista, según la prioridad y complejidad del estado del paciente; quien/es realiza/n indicaciones y coloca su nombre con firma y sello, así como la fecha y hora de la respuesta.*

(…)

6.5.1 SEGURIDAD DEL PACIENTE

Para la seguridad del paciente de la UPSS Cuidados Intensivos se dispone lo siguiente:

(…)

j) *Evaluación continua de riesgos, que incluye el análisis de los incidentes de la seguridad del paciente, como parte de la gestión de riesgos dentro de la UPSS Cuidados Intensivos.*

(…)

MINISTERIO DE SALUD
Aseguramiento e Intercambio Prestacional
C. ALVARADO CH.

6.5.2 PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES

(...)

Del Paciente

a) *La Vigilancia epidemiológica de las IAAS es realizada por el personal responsable de la vigilancia de la Oficina de Epidemiología o el que haga sus veces; con acceso a la UPSS Cuidados Intensivos para recolección de datos y verificación de casos. La UPSS Cuidados Intensivos implementa medidas de prevención y control según corresponda.*

(...)

Del Trabajador

a) *Plan de capacitación sobre: Prevención y Control de Infecciones en la UPSS Cuidados Intensivos, Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, manejo de residuos sólidos, entre otros, para el personal que ingresa a trabajar en la UPSS Cuidados Intensivos, incluido el profesional de Residentado o de segunda especialización.*

(...)

Del Ambiente

a) En la UPSS Cuidados Intensivos se realizan los procedimientos de limpieza y desinfección de establecimientos de salud según normatividad vigente.

(...)

6.6 RECURSOS HUMANOS

a) La UPSS Cuidados Intensivos cuenta con un equipo interdisciplinario de salud conformado por médicos cirujanos especialistas en medicina intensiva, profesional en enfermería especialista en cuidados intensivos y personal técnico (a) en enfermería con capacitación en cuidados intensivos. Complementariamente al equipo interdisciplinario, brindan soporte: el Tecnólogo Médico en terapia física y rehabilitación, el químico farmacéutico, los licenciados en nutrición capacitados en soporte nutricional artificial, los licenciados en psicología y el personal certificado y/o entrenado en soporte de la ventilación artificial, fisioterapia cardiorrespiratoria, trabajadora social, entre otros.

(...)

e) (...)

Tabla N° 3: Relación de número de pacientes por recurso humano en la UPSS Cuidados Intensivos

Personal de Salud	UPSS Cuidados Intensivos		
	Unidad de Cuidados Intensivos	Unidad de Cuidados Intermedios	Cuidados Intensivos Extendidos
Médico especialista en medicina intensiva (medicina intensiva adultos, pediátrica y neonatal)	• Un (01) médico especialista en medicina intensiva por cada 6 pacientes.(***)	• Un (01) médico especialista en medicina intensiva por cada 8 pacientes (***)	• Un (01) médico especialista en medicina intensiva para seguimiento de hasta 8 pacientes hospitalizados fuera de la UPSS Cuidados Intensivos y/o con demanda de más de 8 interconsultas para la UPSS Cuidados Intensivos por día.(*)
Profesional de enfermería especialista en cuidados intensivos	**Escala de NAS (Nursing Activities Score)** [1] • Un (01) profesional de enfermería especialista en cuidados intensivos por 1 paciente si la escala de NAS es mayor al 50% empleado en el paciente en estado crítico. • En Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales la relación es un (01) profesional en enfermería especialista en cuidados intensivos neonatales por cada 2 pacientes (*) **Escalas alternativas:** **NEMS (nine equivalents of Nursing Manpower use score)**[2] • Un (01) profesional en enfermería especialista en cuidados intensivos por un 1 paciente Si la escala de NEMS, es mayor de 34 o si cada TISS* 28 es mayor de 39.	• Un (01) profesional en enfermería especialista en cuidados intensivos por cada 3 pacientes, si estos no dependen de soporte ventilatorio o es de baja complejidad. • Un (01) profesional en enfermería especialista en cuidados intensivos por cada 2 pacientes en estado crítico, si estos dependen de soporte ventilatorio. • En Unidad de Cuidados Intermedios Neonatales la relación es un (01) profesional en enfermería especialista en cuidados intensivos por cada 4-5 neonatos (*)	• Un (01) profesional en enfermería especialista en cuidados intensivos por cada 4 pacientes hospitalizados fuera de la de la UPSS Cuidados Intensivos

C. ALVARADO CH.

[1] Sistema de puntuación, reconocido como descriptor del trabajo de Enfermería en UPSS Cuidados Intensivos y como predictor de la gravedad del paciente.

[2] Sistema de evaluación de la gravedad en la UPSS de Cuidados Intensivos, cuanto más se aparta de los valores establecidos, más grave se encuentra el paciente.

Personal de Salud	UPSS Cuidados Intensivos		
	Unidad de Cuidados Intensivos	Unidad de Cuidados Intermedios	Cuidados Intensivos Extendidos
	TISS-28 (Simplified Therapeutic Intervention Score System) [3] • Un (01) profesional en enfermería especialista en cuidados intensivos por cada 2 pacientes si cada TISS*28, (Simplified Therapeutic Intervention Score System), es menor de 39.		
Técnica(o) en enfermería.	• Un (01) técnica (o) en enfermería por cada 3 pacientes adultos • Un (01) técnica (o) por cada 6 pacientes neonatos.	• Un (01) técnica (o) por cada 4 pacientes sin soporte ventilatorio. • Un (01) técnica (o) por cada 3 pacientes con soporte ventilatorio. • Un (01) técnica (o) por cada 6 pacientes neonatos.	
Personal de Limpieza	La distribución del personal de limpieza se realiza por cada una de las unidades o áreas de la UPSS Cuidados Intensivos de acuerdo a necesidad. (**)		

(*) En el caso de cuidados intensivos e intermedios neonatales la relación de número de paciente por profesional en enfermería varía y en casos de alta tecnología y cuidados de alta dependencia.

(**) Se garantiza que mínimamente la limpieza y desinfección de la UPSS Cuidados Intensivos se realice cada 12 horas y el personal de limpieza permanece en la unidad, o ambiente, dentro de la UPSS Cuidados Intensivos para la limpieza de los ambientes: a demanda, en egresos de la UPSS, ingresos y contingencias.

(***) Esta relación puede ser hasta de 1 a 4, de acuerdo a la complejidad del paciente, autorizado por el médico cirujano especialista en medicina intensiva, gestor de la UPSS Cuidados Intensivos.

(...)

6.6.1 REQUISITOS MÍNIMOS DEL RECURSO HUMANO DE LA UPSS CUIDADOS INTENSIVOS.

Los requisitos mínimos del recurso humano de la UPSS Cuidados Intensivos son:

a) Médico cirujano de la UPSS Cuidados Intensivos:

- *Título Profesional Universitario de Médico Cirujano.*
- *Título de Especialista en Medicina Intensiva.*

[3] Sistema simplificado de puntuación para medir la carga de trabajo de enfermería en las Cuidados Intensivos. Se basa en un listado de 28 intervenciones terapéuticas, a las que se asigna un puntaje según su complejidad e intensidad.

- *Registro Nacional de Especialista en Medicina Intensiva.*
- *Capacitación BLS y/o ACLS, según corresponda.*

(...)

6.6.2.1 Del médico cirujano especialista en medicina intensiva que conduce la gestión clínica de la UPSS Cuidados Intensivos:

(...)

l) Promueve la cultura de seguridad de la atención del paciente, así como el registro y reporte de incidentes de la seguridad del paciente.

(...)

6.6.2.2. Del Médico cirujano especialista en medicina intensiva:
(...)

f) Realiza el proceso del consentimiento informado y deja constancia de ello, consignando la firma del paciente, si éste pudiera realizarla, o de su familiar o representante legal.

(...)

h) Identifica, registra y notifica los incidentes de la seguridad del paciente y participa en la implementación de prácticas seguras en la atención del paciente de la UPSS Cuidados Intensivos.

(...)

k) El médico cirujano especialista en medicina intensiva de los Cuidados Intensivos Extendidos, acude a la respuesta de las interconsultas de las diferentes UPSS del establecimiento de salud y monitorea estrechamente al paciente hasta que se remita su estado crítico, o se considere el manejo paliativo; coordina con la UPSS Cuidados Intensivos si existe la necesidad de ingreso y si se dispone de cama.

(...)

6.6.2.5 Del profesional de enfermería especialista en cuidados intensivos.

(...)

d) Registra de forma oportuna y completa la información clínica/asistencial en la historia clínica y formatos internos que correspondan.

(...)

6.7.3.4 INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS

(...)

k) En las unidades de cuidados intensivos especializados se recomienda la climatización de cada habitación en forma individual.

(...)

MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional
C. ALVARADO CH.

6.9 HUMANIZACIÓN

(…)

Las "puertas abiertas" en la UPSS Cuidados Intensivos considera:

d) ***Incorpora a la familia en el cuidado del paciente:*** *la familia del paciente colabora en algunos cuidados, como el aseo personal, la administración de comidas o la estimulación de ejercicios de fisioterapia, bajo la supervisión del personal de salud de la UPSS cuidados intensivos.*

(…)".

3. Modificar la numeración del inciso 6.6.2 CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, así como lo consignado en el literal c) del mismo inciso 6.6.2, y la numeración de los subincisos 6.6.2.1 y 6.6.2.2, los cuales quedan redactados de la siguiente manera:

"6.6.3. CAPACITACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

(…)

c) En el PDP institucional o en el documento que haga sus veces, se incluyen capacitaciones en: integridad, ética, bioética, prevención y control de infecciones, seguridad del paciente entre otros.

(…)

6.6.3.1 *Capacitación del médico cirujano especialista en medicina intensiva, médico cirujano pediatra especialista en medicina intensiva pediátrica, médico cirujano pediatra con subespecialidad en neonatología y médico cirujano de la especialidad de neonatología.*

(…)

6.6.3.2 *Capacitación del profesional en enfermería de la UPSS Cuidados intensivos:*

(…)".

MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Aseguramiento e Intercambios Prestacionales
C. ALVARADO CH.

4. Modificar el **ANEXO N° 5**, que queda redactado de la siguiente manera:

ANEXO N° 5

INDICADORES DE CALIDAD DE LA UPSS CUIDADOS INTENSIVOS

TIPO	INDICADOR	DEFINICIÓN	FRECUENCIA	RESPONSABLE	ESTÁNDAR	UTILIDAD
De Estructura	**Presencia de Profesional en Enfermería especialista en cuidados intensivos 24 horas** N° de Profesional en Enfermería especialista en cuidados intensivos titulados programados al mes x 100/N° total de Profesional en Enfermería programado al mes.	Porcentaje de Profesional en Enfermería especialista en cuidados intensivos programado mensualmente.	Mensual	Profesional en Enfermería especialista en cuidados intensivos responsable de Enfermería.	> 7 0 % para establecimiento de salud categoría II-2 en Regiones. > 8 0 % para establecimiento de salud categoría III-1 en Regiones. 100% para establecimiento de salud categoría III-1, III-2 en la ciudad de Lima.	Porcentaje debe llegar a 100% cuando se cubra la oferta de Profesional en Enfermería especialista en cuidados intensivos a nivel nacional en forma progresiva y sistemática.
	Porcentaje de equipos biomédicos con mantenimiento preventivo N.º de equipos biomédicos con mantenimiento preventivo x 100 / N.º de equipos biomédicos básicos	Porcentaje de equipos en mantenimiento preventivo de la UPSS Cuidados Intensivos.	Diario, se toma un promedio mensual.	Profesional en Enfermería especialista en cuidados intensivos de Turno.	100%	Permite medir la capacidad de brindar atención con equipamiento biomédico básico.

TIPO	INDICADOR	DEFINICIÓN	FRECUENCIA	RESPONSABLE	ESTÁNDAR	UTILIDAD
	Porcentaje de equipos biomédicos con mantenimiento correctivos N.º de equipos biomédicos con mantenimiento correctivo x 100 / N.º de equipos biomédicos básicos	Porcentaje de equipos en mantenimiento correctivo de la UPSS Cuidados Intensivos.	Diario, se toma un promedio mensual.	Profesional en Enfermería especialista en cuidados intensivos de Turno.	100%	Permite medir la capacidad de brindar atención con equipamiento biomédico básico.
	Porcentaje de equipos biomédicos con mantenimiento de calibración N.º de equipos biomédicos con mantenimiento de calibración x 100 / N.º de equipos biomédicos básicos	Porcentaje de equipos en mantenimiento de calibración de la UPSS Cuidados Intensivos.	Diario, se toma un promedio mensual.	Profesional en Enfermería especialista en cuidados intensivos de Turno.	100%	Permite medir la capacidad de brindar atención con equipamiento biomédico básico.
	Porcentaje de equipos biomédicos operativos N.º de equipos biomédicos operativos x 100 / N.º de equipos biomédicos básicos	Porcentaje de equipos operativos en la UPSS Cuidados Intensivos.	Diario, se toma un promedio mensual.	Profesional en Enfermería especialista en cuidados intensivos de Turno.	100%	Permite medir la capacidad de brindar atención con equipamiento biomédico básico.
De proceso	**Porcentaje de eventos centinela analizados** N.º Eventos centinela analizados x 100/ N.º de Eventos centinela ocurridos	Porcentaje de eventos **centinela** registrados, que tengan análisis causal y planteamiento de mejora en cada año (registro, notificación y gestión: análisis para mejora) en la UPSS Cuidados Intensivos.	Anual	Médico cirujano especialista en medicina intensiva que conduce la gestión clínica de la UPSS Cuidados Intensivos.	100%	Permite medir la cantidad de eventos **centinela** analizados y toma de acciones respectivas.



TIPO	INDICADOR	DEFINICIÓN	FRECUENCIA	RESPONSABLE	ESTÁNDAR	UTILIDAD
	Porcentaje de adherencia a guías de práctica clínica y/o protocolos. Número de Historias Clínicas auditadas que cumplen con las recomendaciones de manejo de la Guías de práctica clínica y/o protocolos, según patología priorizada x 100 /Total de Historias Clínicas de pacientes con patología priorizada que recibieron manejo	Porcentaje de pacientes que son atendidos cumpliendo las Guías de práctica clínica y/o protocolos en la UPSS Cuidados Intensivos.	Mensual	Médico cirujano especialista en medicina intensiva que conduce la gestión clínica de la UPSS Cuidados Intensivos.	100%	Permite medir si la atención del paciente en estado crítico es adecuada a las Guías de práctica clínica y/o protocolos.
	Densidad de incidencia de Neumonía asociada a ventilador mecánico (NAVM) Número de casos de Neumonía asociada a ventilador mecánico (NAVM) x 100/ Total, de días de exposición al ventilador mecánico	Indicador que mide la cantidad de neumonías asociadas a los días de exposición del ventilador mecánico.	Mensual	El personal que realiza la vigilancia de IAAS de la Oficina de epidemiología o el que haga sus veces, en su calidad de instancia encargada de la conducción, recolección, validación, análisis, consolidación y notificación de la información, conforme a la NTS N° 163-MINSA/2020/CDC, es el responsable de los indicadores de vigilancia epidemiológica de las IAAS.	<5 x 1000 días VM (II-2); < 7 x 1000 días VM (III-1, III-2)	Junto a otros indicadores permite evaluar la calidad de la atención en Cuidados Intensivos como en otras áreas hospitalarias.

TIPO	INDICADOR	DEFINICIÓN	FRECUENCIA	RESPONSABLE	ESTÁNDAR	UTILIDAD
	Densidad de incidencia de infección asociada a Catéter Venoso Central **(CVC)** Número de casos de Infección por CVC x 100/ Total, de días de exposición al CVC	Indicador que mide la cantidad de infecciones del torrente sanguíneo asociadas a los días de exposición al catéter venoso central.	Mensual	El personal que realiza la vigilancia de IAAS de la Oficina de epidemiología o el que haga sus veces, en su calidad de instancia encargada de la conducción, recolección, validación, análisis, consolidación y notificación de la información, conforme a la NTS N° 163-MINSA/2020/CDC, es el responsable de los indicadores de vigilancia epidemiológica de las IAAS.	< 6 x 1000 días CVC (II-2) < 7 x 1000 días CVC (III-1, III-2)	Junto a otros indicadores permite evaluar la calidad de la atención en Cuidados Intensivos como en otras áreas hospitalarias.



TIPO	INDICADOR	DEFINICIÓN	FRECUENCIA	RESPONSABLE	ESTÁNDAR	UTILIDAD
	Densidad de incidencia de infección asociada a catéter urinario Número de casos de infección urinaria x 100/ Total, de días de exposición a la sonda urinaria	Indicador que mide la cantidad de infecciones urinarias asociadas a los días de exposición de la sonda urinaria.	Mensual	El personal que realiza la vigilancia de IAAS de la Oficina de epidemiología o el que haga sus veces, en su calidad de instancia encargada de la conducción, recolección, validación, análisis, consolidación y notificación de la información, conforme a la NTS N° 163-MINSA/2020/CDC, es el responsable de los indicadores de vigilancia epidemiológica de las IAAS.	< 4 x 1000 días catéter urinario	Junto a otros indicadores permite evaluar la calidad de la atención en Cuidados Intensivos como en otras áreas hospitalarias.
	Porcentaje de retiro accidental de catéteres vasculares (CV) N.º de CV retirados accidentalmente x 100 / N º de días de CV por pacientes hospitalizados por mes	Porcentaje de catéteres vasculares que son retirados accidentalmente por el personal en enfermería de la UPSS Cuidados Intensivos.	Mensual	Profesional en Enfermería especialista en cuidados intensivos de Turno.	Catéter arterial: 15 catéteres por 1000 días CVC y CVP: 06 catéteres por 1000 días	El retiro accidental de catéteres afecta de manera directa a la seguridad del paciente, supone un aumento del riesgo de complicaciones.

TIPO	INDICADOR	DEFINICIÓN	FRECUENCIA	RESPONSABLE	ESTÁNDAR	UTILIDAD
	Incidencia de lesiones por presión (LPP) grado 3 o 4 Número de UPP que se producen x 1000/Número de estancias.	En la implementación de Prácticas de Seguridad del Paciente este indicador mide el porcentaje de lesiones por presión desarrolladas en pacientes hospitalizados en la UPSS Cuidados Intensivos.	Mensual	Profesional en Enfermería especialista en cuidados intensivos responsable de Enfermería.	0%	La utilización de protocolos relacionados con la seguridad del enfermo y medidas de restricción puede disminuir su incidencia.
	Incidencia de errores de medicación discriminando por medicamentos de alto riesgo y otros. Nº total de errores de medicación comunicados x 100 /N.º total de administraciones de medicación.	En la implementación de Prácticas de Seguridad del Paciente este indicador mide el Porcentaje de errores de administración de medicamentos comunicados en la UPSS Cuidados Intensivos.	Mensual.	Profesional en Enfermería especialista en cuidados intensivos responsable de Enfermería	0%	Los errores de medicación son los incidentes más frecuentes en la UPSS Cuidados Intensivos y se asocian a un incremento de la morbilidad, mortalidad, estancia y costes.
	Razón de incidentes de la seguridad del paciente por egresos hospitalarios de la UPSS Cuidados Intensivos Número de **incidentes de la seguridad del paciente** por egreso x 100 / Total de egresos en el mismo período.	Relación entre los Incidentes relacionados con la seguridad del paciente que presentan los pacientes que egresan de la UPSS Cuidados Intensivos y el total de los egresos de los pacientes.	Mensual	Médico cirujano especialista en medicina intensiva que conduce la gestión clínica de la UPSS Cuidados Intensivos.	< 5% del total de egresos	Su valor permite evaluar los Incidentes relacionados con la seguridad del paciente que presentan los pacientes que egresan de la UPSS Cuidados Intensivos y conocer los factores intrínsecos, extrínsecos que están presentes en la aparición de éstos, a fin de tomar medidas para evitarlos y la disminuir su gravedad.

TIPO	INDICADOR	DEFINICIÓN	FRECUENCIA	RESPONSABLE	ESTÁNDAR	UTILIDAD
De Resultados	**Razón de mortalidad estandarizada en la UPSS Cuidados Intensivos o Mortalidad indexada al APACHE II** Mortalidad neta (fallecidos post 48 horas) x 100 / Total, de pacientes admitidos en el mismo período Mortalidad esperable por APACHE II en el mismo periodo de tiempo	Relación entre la Mortalidad neta de la UPSS Cuidados Intensivos y la mortalidad esperable del paciente según su riesgo de muerte a la admisión (dada por el score pronóstico APACHE II). Fuente de dato: Registro de Score APACHE II.	Mensual.	Médico cirujano especialista en medicina intensiva que conduce la gestión clínica de la UPSS Cuidados Intensivos.	< 1.1	Su valor permite la comparación entre las diferentes UPSS de Cuidados Intensivos del mismo tipo de otros hospitales. Se espera que ambas tasas sean muy parecidas. De ser mayor el estándar, reflejaría un exceso de mortalidad para lo esperable.
	Porcentaje de pacientes con lesiones por flebitis (N° de pacientes hospitalizados con flebitis en un período / N° de pacientes hospitalizados en UCI con catéter venoso periférico en el mismo período) x 100	Porcentaje de pacientes hospitalizados en la UPSS Cuidados Intensivos, que tienen lesiones por flebitis.	Mensual	Profesional en Enfermería especialista en cuidados intensivos responsable de Enfermería.	< 15%	Mide la calidad de la intervención de enfermería respecto a la correcta aplicación de catéteres venosos periféricos (venoclisis), en pacientes hospitalizados en UCI.
	Mortalidad oculta o mortalidad de los egresos de la UPSS Cuidados Intensivos hasta las 72 horas, indexada al APACHE II. Mortalidad oculta o de los egresos de la UPSS Cuidados (fallecidos post 72 horas) x 100 / Total, de pacientes egresados en el mismo período.	Relación entre la Mortalidad de los egresos de la UPSS Cuidados Intensivos versus la mortalidad esperable del paciente según su riesgo de muerte al egreso.	Mensual	Médico cirujano especialista en medicina intensiva que conduce la gestión clínica de la UPSS Cuidados Intensivos.		Su valor permite evaluar las características de los pacientes tales como comorbilidades asociadas, parámetros fisiológicos y bioquímicos diferentes entre los pacientes que egresaron de la UPSS Cuidados Intensivos

TIPO	INDICADOR	DEFINICIÓN	FRECUENCIA	RESPONSABLE	ESTÁNDAR	UTILIDAD
						que vivieron y los que fallecieron.
	Reingreso a la UPSS Cuidados Intensivos N.º de pacientes que salieron de la UPSS CI que son reingresados dentro de las 48 horas de su salida de la UPSS CI x 100/ N.º total de egresos	Porcentaje de pacientes que regresan a la UPSS Cuidados Intensivos dentro de las 48 horas desde la salida de ésta.	Mensual	Médico cirujano especialista en medicina intensiva	4 a 14%	Junto a otros indicadores permite evaluar la calidad de la atención en Cuidados Intensivos como en otras áreas hospitalarias.
	Porcentaje de caídas del paciente Número de caídas que se producen x 100/Número de estancias.	En la implementación de Prácticas de Seguridad del Paciente este indicador mide el porcentaje de caídas de pacientes hospitalizados en la UPSS Cuidados Intensivos.	Mensual	Profesional en Enfermería especialista en cuidados intensivos responsable de Enfermería.	0%	Las caídas accidentales pueden provocar lesiones a los enfermos, además de influir negativamente en la calidad percibida. Es un evento evitable.
	Demanda Insatisfecha en Cuidados Intensivos **N.º de pacientes que NO ingresan a la UPSS Cuidados intensivos por falta de camas x 100/** Número total de pacientes con indicación de ingreso	Porcentaje de pacientes en estado crítico con indicación de manejo en la UPSS Cuidados Intensivos (Unidad de Cuidados Intensivos e Unidad de Cuidados Intermedios) pero que no pueden acceder por falta de camas.	Por turno de 12 horas.	Médico cirujano especialista en medicina intensiva de turno, o guardia.	0%	Mide la efectividad de la gestión hospitalaria para poder solucionar la continuidad de la atención. Su medición a este nivel permite medir la Gestión hospitalaria en su conjunto.



TIPO	INDICADOR	DEFINICIÓN	FRECUENCIA	RESPONSABLE	ESTÁNDAR	UTILIDAD
		Fuente de dato: Registro de Interconsultas.				
	Número de familiar o representante de pacientes hospitalizados en la UPSS Cuidados Intensivos que reciben informe médico de acuerdo con la directiva del establecimiento de salud Número de familiar o representante por paciente hospitalizado en la UPSS Cuidados Intensivos que recibe/n informe x 100/ Número total de pacientes hospitalizados en la UPSS Cuidados Intensivos por mes	Porcentaje de familiar o representante de pacientes hospitalizados en la UPSS Cuidados Intensivos que reciben informe médico	Mensual	Profesional en Enfermería especialista en cuidados intensivos responsable de Enfermería.	100%	Información que se brinda a familiar del paciente a fin del conocimiento de su evolución y pronóstico

- Adicionalmente se incluyen Scores e indicadores propios de la especialidad a la que se dedican las unidades de cuidados intensivos especializados, según corresponda.

5. Modificar el **ANEXO N° 12,** que queda redactado de la siguiente manera:

ANEXO N°12

REGISTRO DIARIO DE ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS MÉDICOS EN LA UPSS CUIDADOS INTENSIVOS *

Fecha: .....**Turno:** (D) (N)**.....Hora**.....

Médico cirujano especialista en medicina intensiva

Nombre: .....

Especialidad: .....

RNE (registro nacional de especialista) .....

I. Pacientes

Ítems	N°
1. Camas ocupadas.	
2. Ingresos en el turno.	
3. Reingresos en el turno.	
4. Salidas de la UPSS CI.	
5. Fallecidos.	
6. Otro:	

II. Procedimientos Médicos Invasivos

Procedimiento	Tipo	Acceso	Intentos	Complicación
Colocación de Catéter central.				
Colocación de Catéter arterial.				
Colocación de Marcapaso externo.				
Colocación de Swan Ganz				
Colocación de Tubo Oro Traqueal.				

MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional
C. ALVARADO CH.

Punción lumbar.				
Toracocentesis.				
Toracotomía.				
Paracentesis.				
Pericardiocentesis.				
Hemocultivo.				
Mielocultivo.				
Peritoneo diálisis.				
Reanimación Cardio Pulmonar Cerebral.				
Nutrición Parenteral.				
Cardioversión.				
Traqueostomía.				
Extubación.				
Otro:				

III. Actividades Cuidados Intensivos extendidos

Actividad	N°
1. Interconsultas.	
2. Colocación de Tubo Oro Traqueal.	
3. Reanimación Cardio Pulmonar Cerebral.	
4. Colocación de Catéteres (especificar).	
5. Ultrasonido.	
6. Otro:	

MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional
C. ALVARADO CH.

IV. Equipo para Reanimación Cardio Pulmonar Cerebral

- Número de Equipos:
- Operativo (SI) (NO)

V. Registro de APACHE II

Camas:	Valor
Promedio	

VI. TISS

VI. Registro de TISS

Cama	Valor
Promedio	

VII. Incidentes de la seguridad del paciente (Registro en formato establecido)

.....

.....

.....

.....

VIII. Demanda Insatisfecha

.....

.....

.....

Para los establecimientos de salud que disponen de sistema informático y/o sistematizado, estos parámetros serán registrados en los sistemas disponibles como historia clínica electrónica o informática, módulo de interconsultas u otros que haya desarrollado la UPSSS Cuidados Intensivos en coordinación con la Oficina de Estadística e Informática del establecimiento de salud.

6. Modificar el **ANEXO N° 16,** que queda redactado de la siguiente manera:

ANEXO N° 16

PRINCIPALES PRESTACIONES DE SALUD DE LA CARTERA DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD QUE SE LLEVAN A CABO EN LA UPSS CUIDADOS INTENSIVOS

UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS DE SALUD (UPSS)	PRESTACIONES DE SALUD	DESCRIPCIÓN
UPSS CUIDADOS INTENSIVOS	Atención en la Unidad de Cuidados Intensivos Generales	Atención en Sala de Cuidados Intensivos Generales, por médico cirujano especialista en medicina intensiva y equipo interdisciplinario, a pacientes críticamente enfermos en condición de inestabilidad y gravedad persistente, que requieren atención de salud durante las 24 horas del día. Incluye atención a pacientes aislados.
UPSS CUIDADOS INTENSIVOS	Atención en la Unidad de Cuidados Intermedios Generales	Atención en Sala de Cuidados Intermedios General, por médico cirujano especialista en medicina intensiva y equipo interdisciplinario, a pacientes críticamente enfermos en condición de estabilidad; pero que su estado aún reviste gravedad, y que requieren atención de salud durante las 24 horas del día. Incluye atención a pacientes aislados.
UPSS CUIDADOS INTENSIVOS	Atención en Cuidados Intensivos Extendidos a pacientes en estado crítico fuera de la UPSS Cuidados Intensivos	Atención a pacientes en estado crítico, en el marco de la continuidad de atención del paciente crítico, en el lugar y contexto de origen (UPSS Hospitalización o UPSS Emergencia), que no pueden acceder a la UPSS Cuidados Intensivos por falta de disponibilidad de cama. Esta atención se comparte por responsabilidad con el personal médico cirujano de la UPSS de origen del paciente.
UPSS CUIDADOS INTENSIVOS	Atención en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales	Atención en Sala de Cuidados Intensivos Neonatal, por médico cirujano especialista en neonatología o médico cirujano especialista en pediatría con subespecialidad en neonatología, que desarrolla servicio de salud subespecializado de medicina intensiva neonatal y equipo interdisciplinario de salud, a neonatos críticamente enfermos en condición de inestabilidad y gravedad persistente, que requieren atención especializada durante las 24 horas del día. Incluye atención para neonatos aislados.
UPSS CUIDADOS INTENSIVOS	Atención en la Unidad de Cuidados Intermedios Neonatales	Atención en Sala de Cuidados Intermedios Neonatal, por médico cirujano especialista en neonatología o médico cirujano especialista en pediatría con subespecialidad en neonatología, que desarrolla servicio de salud subespecializado de medicina intensiva neonatal y equipo interdisciplinario, a neonatos críticamente enfermos en condición de estabilidad; pero que su estado aún reviste gravedad, que requieren atención de salud durante las 24 horas del día. Incluye atención a neonatos aislados.



UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS DE SALUD (UPSS)	PRESTACIONES DE SALUD	DESCRIPCIÓN
UPSS CUIDADOS INTENSIVOS	Atención en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos	Atención en Sala de Cuidados Intensivos Pediátricos, por médico cirujano especialista en pediatría y subespecialista en medicina intensiva pediátrica a pacientes pediátricos críticamente enfermos en condición de inestabilidad y gravedad persistente, que requieren atención de salud durante las 24 horas del día. Incluye atención a pacientes pediátricos aislados.
UPSS CUIDADOS INTENSIVOS	Atención en la Unidad de Cuidados Intermedios Pediátricos	Atención en Sala de Cuidados Intermedios Pediátrico, por médico cirujano especialista en medicina intensiva pediátrica y equipo interdisciplinario de salud, a pacientes pediátricos críticamente enfermos en condición de estabilidad; pero que su estado aún reviste gravedad, que requieren atención de salud durante las 24 horas del día. Incluye atención a pacientes pediátricos aislados.
UPSS CUIDADOS INTENSIVOS	Atención en la Unidad de Cuidados Intensivos Especializados (especificar)	Atención en sala de cuidados intensivos especializados (especificar: cardiológica, neuroquirúrgica, oncológica, de ginecología y obstetricia, ginecológica, obstétrica, de cirugía de tórax y cardiovascular, de quemados, entre otras) por médico cirujano de la especialidad correspondiente (especificar) con entrenamiento en cuidados intensivos, o médico cirujano especialista en medicina intensiva con entrenamiento en cuidados intensivos de la especialidad correspondiente (especificar) y equipo interdisciplinario de salud, a pacientes críticamente enfermos en condición de inestabilidad y gravedad permanente, que requieren atención especializada durante las 24 horas del día. Incluye atención a pacientes aislados.
UPSS CUIDADOS INTENSIVOS	Atención en la Unidad de Cuidados Intermedios de otras especialidades médicas y quirúrgicas (especificar) Atención en la Unidad de Cuidados Intermedios especializados (especificar)	Atención en sala de cuidados intermedios especializados (especificar: cardiológica, neuroquirúrgica, oncológica, de ginecología y obstetricia, ginecológica, obstétrica, de cirugía de tórax y cardiovascular, de quemados, entre otras) por médico cirujano de la especialidad correspondiente (especificar) con entrenamiento en cuidados intensivos o por médico cirujano especialista en medicina intensiva con entrenamiento en cuidados intensivos de la especialidad correspondiente (especificar) y equipo interdisciplinario de salud, a pacientes críticamente enfermos en condición de estabilidad, pero que su estado aún reviste gravedad. Incluye atención a pacientes aislados.
UPSS CUIDADOS INTENSIVOS	Atención de Soporte Nutricional Parenteral Total para pacientes	Atención con fórmulas parenterales por médico cirujano especialista en medicina intensiva, con apoyo de profesional en enfermería especialista, capacitados en soporte nutricional a pacientes críticamente enfermos en sala de cuidados intensivos y sala de cuidados intermedios, que requieren de soporte nutricional parenteral total de acuerdo a necesidad.
UPSS CUIDADOS INTENSIVOS	Atención de Soporte Respiratorio en alto flujo, ventilación mecánica invasiva o no invasiva o post ventilación mecánica	Atención con intervención en la programación de alto flujo, ventilación mecánica o protocolos de destete/de canulación con sin terapia farmacológica adyuvante por médico cirujano especialista en medicina intensiva, con apoyo de profesional en enfermería especialista, capacitados en soporte respiratorio avanzado a pacientes críticamente enfermos en sala de cuidados intensivos y sala de cuidados intermedios u UPSS Hospitalización que requieren de evaluación para toma de decisiones en el soporte ventilatorio artificial o retiro del mismo de acuerdo a necesidad.



UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS DE SALUD (UPSS)	PRESTACIONES DE SALUD	DESCRIPCIÓN
UPSS CUIDADOS INTENSIVOS	Junta médica en cuidados intensivos	Atención de salud (consulta u opinión médica) realizada por dos o más médicos cirujanos de distintas especialidades o subespecialidades con participación del médico cirujano especialista en medicina intensiva que conduce la gestión clínica de la UPSS Cuidados Intensivos y el médico cirujano especialista en medicina intensiva de turno, según corresponda, que se constituyen para la toma de decisión conjunta respecto al diagnóstico, tratamiento y pronóstico de un paciente en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos o unidad de cuidados intermedios, generales o especializados, solicitada por el médico cirujano tratante; en ambiente específico donde se comparte, revisa y se discute la información clínica de la historia clínica.
UPSS CUIDADOS INTENSIVOS	Telejunta médica en cuidados intensivos	Atención de salud (consulta u opinión médica) a distancia mediante el uso de tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) realizada por dos o más médicos cirujanos de distintas especialidades o subespecialidades médicas del establecimiento de salud o de otros establecimientos de salud, en ambiente específico, para la toma, en conjunto, de decisión médica respecto el diagnóstico, terapéutica y pronóstico de un paciente en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos o unidad de cuidados intermedios, generales o especializados, a solicitud del médico cirujano tratante.
UPSS CUIDADOS INTENSIVOS	Teleatención en la unidad de cuidados intensivos generales	Consulta a distancia mediante el uso de tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) realizada por médico cirujano especialista en medicina intensiva a médico cirujano especialista de una unidad de cuidados intensivos especializados; en ambiente específico, para segunda opinión de pacientes críticamente enfermos en condición de inestabilidad y gravedad persistente, cumpliendo las normas vigentes relacionadas a la prescripción, y la firma manuscrita o firma digital o firma electrónica, que respalda el acto prescriptivo.
UPSS CUIDADOS INTENSIVOS	Teleatención en la unidad de cuidados intermedios generales	Consulta a distancia mediante el uso de tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) realizada por médico especialista en medicina intensiva a médico cirujano especialista de una unidad de cuidados intermedios especializados; en ambiente específico, para segunda opinión de pacientes críticamente enfermos en condición de estabilidad, pero que su estado aún reviste gravedad, cumpliendo las normas vigentes relacionadas a la prescripción, y la firma manuscrita o firma digital o firma electrónica, que respalda el acto prescriptivo.
UPSS CUIDADOS INTENSIVOS	Teleatención en la unidad de cuidados intensivos neonatales	Consulta a distancia mediante el uso de tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) realizada por médico cirujano especialista en neonatología o médico cirujano especialista en pediatría con subespecialidad en neonatología, que desarrolla servicio de salud subespecializado de medicina intensiva neonatal a médico especialista de una unidad de cuidados intensivos especializados; en ambiente específico, para segunda opinión de neonatos críticamente enfermos en condición de inestabilidad y gravedad persistente, cumpliendo las normas vigentes relacionadas a la prescripción, y la firma manuscrita o firma digital o firma electrónica, que respalda el acto prescriptivo.

MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional
C. ALVARADO CH.

UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS DE SALUD (UPSS)	PRESTACIONES DE SALUD	DESCRIPCIÓN
UPSS CUIDADOS INTENSIVOS	Teleatención en la unidad de cuidados intermedios neonatales	**Consulta a distancia mediante el uso de tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) realizada por médico cirujano especialista en neonatología o médico cirujano especialista en pediatría con subespecialidad en neonatología, que desarrolla servicio de salud subespecializado de medicina intensiva neonatal a médico especialista de una unidad de cuidados intermedios especializados; en ambiente específico, para segunda opinión de neonatos enfermos en condición de estabilidad, pero que su estado aún reviste de gravedad, cumpliendo las normas vigentes relacionadas a la prescripción, y la firma manuscrita o firma digital o firma**
UPSS CUIDADOS INTENSIVOS	Teleatención en la unidad de cuidados intensivos pediátricos	**Consulta a distancia mediante el uso de tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) realizada por médico cirujano especialista en pediatría y subespecialista en medicina intensiva pediátrica que desarrolla servicio de salud subespecializado de medicina intensiva pediátrica a médico cirujano especialista de una unidad de cuidados intensivos especializados; en ambiente específico, para segunda opinión de pacientes pediátricos críticamente enfermos en condición de inestabilidad y gravedad persistente, cumpliendo las normas vigentes relacionadas a la prescripción, y la firma manuscrita o firma digital o firma electrónica, que respalda el acto prescriptivo.**
UPSS CUIDADOS INTENSIVOS	Teleatención en la unidad de cuidados intermedios pediátricos	**Consulta a distancia mediante el uso de tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) realizada por médico cirujano especialista en pediatría y subespecialista en medicina intensiva pediátrica que desarrolla servicio de salud subespecializado de medicina intensiva pediátrica a médico cirujano especialista de una unidad de cuidados intermedios especializados; en ambiente específico, para segunda opinión de pacientes pediátricos críticamente enfermos en condición de estabilidad, pero que su estado aún reviste gravedad, cumpliendo las normas vigentes relacionadas a la prescripción, y la firma manuscrita o firma digital o firma electrónica, que respalda el acto prescriptivo.**
UPSS CUIDADOS INTENSIVOS	Teleatención en la unidad de cuidados intensivos especializados (especificar)	Consulta a distancia mediante el uso de tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) realizada por médico cirujano especialista (especificar) con subespecialidad (especificar) y con entrenamiento en cuidados intensivos (especificar) o médico cirujano especialista en medicina intensiva con entrenamiento en cuidados intensivos de la especialidad (especificar a médico cirujano especialista de una unidad de cuidados intensivos de especializados en ambiente específico, para segunda opinión de pacientes críticamente enfermos en condición de inestabilidad y gravedad persistente, cumpliendo las normas vigentes relacionadas a la prescripción, y la firma manuscrita o firma digital o firma electrónica, que respalda el acto prescriptivo.

C. ALVARADO CH.

UNIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS DE SALUD (UPSS)	PRESTACIONES DE SALUD	DESCRIPCIÓN
UPSS CUIDADOS INTENSIVOS	Teleatención en la unidad de cuidados intermedios especializados (especificar)	Consulta a distancia mediante el uso de tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) realizada por médico cirujano especialista (especificar) con subespecialidad (especificar) y con entrenamiento en cuidados intensivos (especificar) o médico cirujano especialista en medicina intensiva a médico cirujano especialista de una unidad de cuidados intermedios especializados; en ambiente específico, para segunda opinión de pacientes críticamente enfermos en condición de estabilidad, pero que su estado aún reviste de gravedad, cumpliendo las normas vigentes relacionadas a la prescripción, y la firma manuscrita o firma digital o firma electrónica, que respalda el acto prescriptivo.
UPSS CUIDADOS INTENSIVOS	Teleseguimiento en la unidad de cuidados intensivos generales	Seguimiento en la atención de salud o monitoreo clínico a distancia mediante el uso de tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) realizada por médico cirujano especialista en medicina intensiva para identificación de signos de alarma, señales biológicas por medio de sensores, entre otros, de pacientes en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos o unidad de cuidados intermedios, mediante la transferencia de información clínica o parámetros biomédicos o exámenes auxiliares, que se pueden transmitir a una ubicación remota al médico cirujano especialista; en ambiente específico.
UPSS CUIDADOS INTENSIVOS	Teleseguimiento en la unidad de cuidados intensivos pediátricos	Seguimiento en la atención de salud o monitoreo clínico a distancia mediante el uso de tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) realizada por médico cirujano especialista en pediatría y subespecialista en medicina intensiva pediátrica para identificación de signos de alarma, señales biológicas por medio de sensores, entre otros, de pacientes en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos o unidad de cuidados intermedios, mediante la transferencia de información clínica o parámetros biomédicos o exámenes auxiliares, que se pueden transmitir a una ubicación remota al médico especialista; en ambiente específico.
UPSS CUIDADOS INTENSIVOS	Teleseguimiento en la unidad de cuidados intensivos especializados (especificar)	Seguimiento en la atención de salud o monitoreo clínico a distancia mediante el uso de tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) realizada por médico cirujano especialista en medicina intensiva con entrenamiento en cuidados intensivos de la especialidad correspondiente (especificar) o médico cirujano de la especialidad correspondiente (especificar) con entrenamiento en cuidados intensivos para identificación de signos de alarma, señales biológicas por medio de sensores, entre otros, de pacientes en estado crítico, mediante la transferencia de información clínica o parámetros biomédicos o exámenes auxiliares, que se pueden transmitir a una ubicación remota al médico especialista; en ambiente específico de la sala de cuidados intensivos especializados (especificar: cardiológica, neuroquirúrgica, oncológica, de ginecología y obstetricia, ginecológica, obstétrica, de cirugía de tórax y cardiovascular, de quemados, entre otras) .

MINISTERIO DE SALUD
Dirección General de Aseguramiento e Intercultural Prestaciones
C. ALVARADO CH.